PROTOCOLO UNIFICADO DE DOLOR TORÁCICO Y SCA — CHGUV 2026

Hoja de Ruta Operativa Integrada: Servicio de Urgencias · Servicio de Cardiología (UCC y Hemodinámica)

CONSORCI HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI VALÈNCIA

■ 1. SCACEST (<90 min) Y SCASEST MUY ALTO RIESGO (<2 h)

• **SCACEST / Código Infarto:** Box Críticos → Sala Hemodinámica (< 90 min) → UCC. En Urgencias administrar **SOLO AAS 300 mg** (el 2.º antiagregante y el bolo de HNF se administran en Sala de Hemodinámica para evitar dobles dosis).

• **SCASEST Muy Alto Riesgo (< 2 h, 24/7):** Inestabilidad, dolor refractario, EAP o TV/FV. **SOLO AAS 300 mg** en Urgencias → Avisar Cardiólogo → Hemodinámica → UCC.

■ 2A. IAMSEST (CURVA AGUDA) O ANGINA INESTABLE (3 CRITERIOS)

• **Circuito CHGUV (Barthel ≥ 30):** Monitorizar en **Observación A**, dar **SOLO AAS 300 mg** y **comentar con el Cardiólogo de Guardia** → Planta Telemetría / UCC.

• **Anticoagulación y 2.º Antiagregante (Protocolo UCO CHGUV):** Al ingreso se pauta **Fondaparinux (Arixtra®) 2,5 mg/24h s.c.**; el 2.º antiagregante solo se administra cuando actúa como puente al cateterismo.

■ 2B. SCASEST EN > 80 AÑOS CON DEPENDENCIA SEVERA (BARTHEL < 30)

• **Manejo Conservador en Urgencias:** Pacientes > 80 años sin elevación del ST con **Índice de Barthel < 30**.

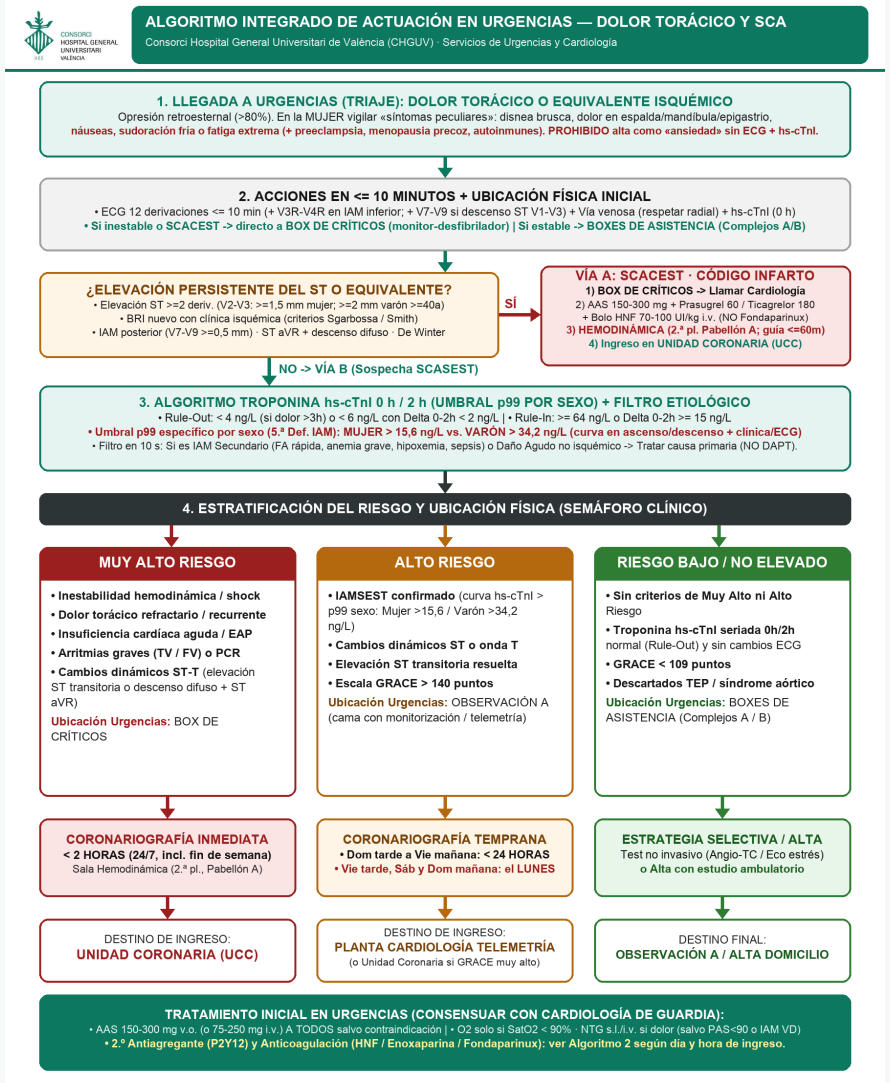
• **Alta tras 5 h sin angina:** Si permanecen sin angina tras 5 horas de observación en Urgencias, se dan de alta desde Urgencias con **AAS + Clopidogrel + Bisoprolol/Amlodipino + parche de NTG 5 mg** (evitando ingresos fútiles).

■ 3. BAJO RIESGO (RULE-OUT) Y TROPONINA PLANA (DELTA < 20%)

• **Rule-Out 0h/2h o Troponina Plana Crónica:** Si hs-cTnI 0h/2h ≤ p99 (Mujer ≤15,6 / Hombre ≤34,2 ng/L) O está discretamente elevada pero **plana (Δ < 20%, ej. 24 → 26 ng/L)** con ECG normal y **sin cumplir los 3 criterios de Angina Inestable → Alta / Manejo por Urgencias SIN llamar a Cardiología**.

ALGORITMO 1: PUERTA DE ENTRADA, DIAGNÓSTICO POR SEXO Y SEMÁFORO SC

Integración del algoritmo 0h/2h de hs-cTnI, particularidades en la mujer y ubicación física en el CHGUV

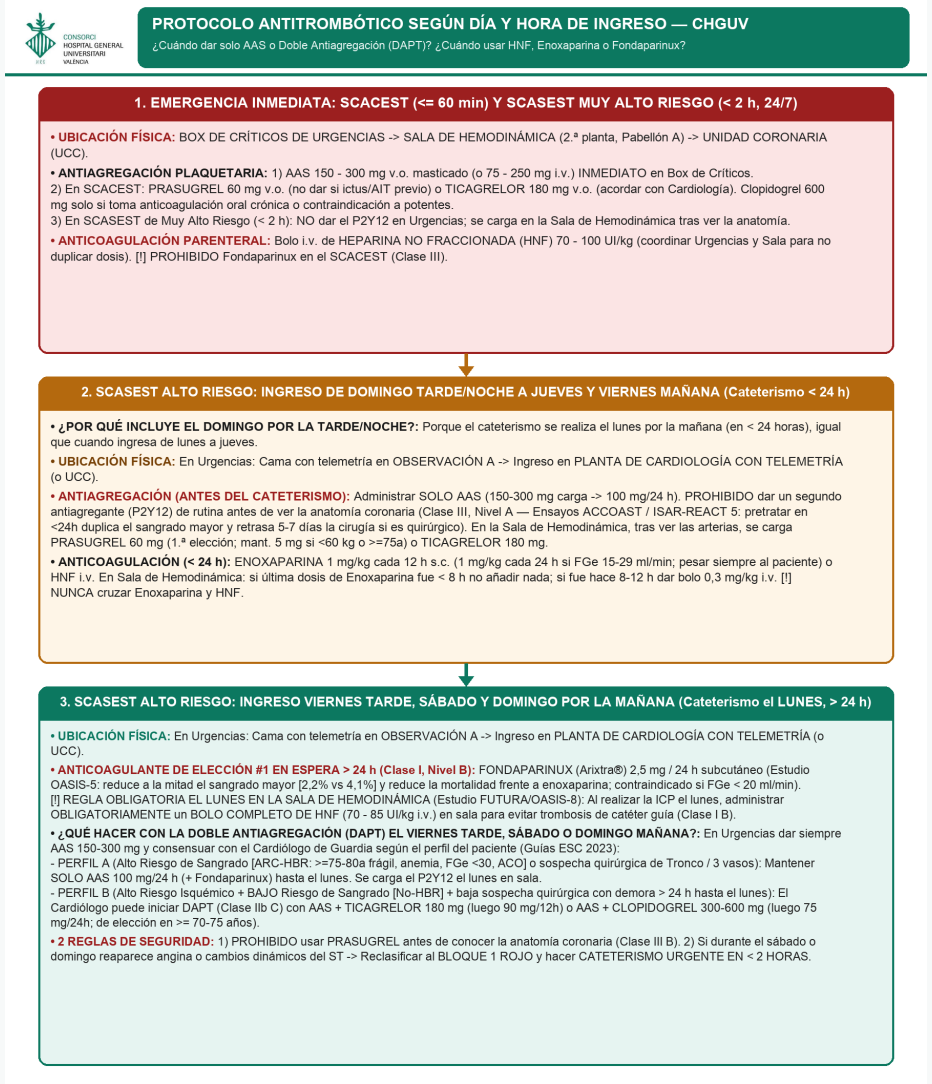


CLAVES DEL ALGORITMO 1

- **ECG en ≤ 10 min:** Registrado y firmado. Añadir V3R-V4R en IAM inferior y V7-V9 si descenso ST en V1-V3.
- **Atención a la Mujer:** Vigilar clínica peculiar (espalda interescapular, mandíbula, epigastrio, disnea súbita, fatiga) y **SCAD** en ≤ 55 años / periparto.
- **Umbral hs-cTnI CHGUV:**
  - **Mujer: > 15,6 ng/L**
  - **Hombre: > 34,2 ng/L**
- **Filtro IAM Tipo 2:** Si hay taquiarritmia, anemia severa, hipoxemia o sepsis activa → tratar la causa primaria sin DAPT ni cateterismo urgente.
- **Comentario con Cardiología:** Urgencias no ingresa directamente; todo SCASEST se comenta con el Cardiólogo de Guardia.

ALGORITMO 2: PAUTA ANTITROMBÓTICA SEGÚN DÍA Y HORA DE INGRESO

Domingo tarde a Viernes mañana (< 24 h) vs. Viernes tarde, Sábado y Domingo por la mañana (> 24 h hasta el Lunes)



REGLAS DE SEGURIDAD EN SALA

- **Ventana < 24 h (Dom tarde a Vie mañana): SOLO AAS 300 mg** + Enoxaparina s.c. Prohibido pretratar con P2Y12 (Clase III ESC).
- **Ventana Fin de Semana (Vie tarde, Sáb y Dom mañana): Fondaparinux 2,5 mg/24h s.c.** es el anticoagulante de 1.ª elección (OASIS-5).
- **¡REGLA OBLIGATORIA EL LUNES!:** Si lleva Fondaparinux, administrar **Bolo de HNF 70–85 UI/kg i.v.** al iniciar el cateterismo en Sala.
- **DAPT en Fin de Semana:** Si ≥75a / HBR → SOLO AAS. Si <75a No-HBR + NSTEMI → consensuar con Cardiólogo añadir Ticagrelor 180 mg o Clopidogrel.
- **Rescate 24/7:** Si reaparece dolor o cambios ST el fin de semana → Cateterismo en < 2 h.

DEFINICIÓN DE ANGINA INESTABLE EN URGENCIAS (CHGUV) Y CASOS CLÍNICOS

Los 3 criterios clínicos estrictos, matiz en la mujer, troponina plana y manejo en > 80 años con Barthel < 30

■ LOS 3 CRITERIOS DE ANGINA INESTABLE EN URGENCIAS (CON TROPONINA NEGATIVA O PLANA)

• **Criterio 1 (In crescendo / Reposo recurrente):** Dolor torácico opresivo de repetición (**> 1 episodio**) con disminución del umbral de esfuerzo de aparición o con clínica en reposo.

• **Criterio 2 (De novo < 2 meses):** Dolor torácico opresivo de repetición con los esfuerzos (o estrés emocional) de inicio hace **menos de 2 meses**.

• **Criterio 3 (Episodio único típico completo):** Único episodio de dolor torácico con **múltiples características anginosas simultáneas**: opresivo + irradiación a miembros superiores, mandíbula o región interescapular + **cortejo vegetativo asociado** (sudoración fría, náuseas/vómitos o disnea súbita). *(En todos los casos descartar otras causas).*

• ■ **Matiz en la Mujer:** Valorar especialmente irradiación a **espalda interescapular, mandíbula o epigastrio**, disnea brusca, náuseas o fatiga extrema, y sospecha de **SCAD** en ≤ 55 años / periparto.

■ REGLAS CLAVE PARA EVITAR LLAMADAS E INGRESOS INADECUADOS EN CARDIOLOGÍA

• **1) Troponina discretamente elevada pero PLANA (Δ < 20%, ej. 24 → 26 ng/L) sin cumplir los 3 criterios de Angina Inestable:** Es una **elevación basal crónica estable** (edad, HTA, HVI o función renal). **NO pedir 3.ª troponina ni llamar a Cardiología → Alta / manejo por Urgencias.**

• **2) Pacientes > 80 años sin elevación del ST con Índice de Barthel < 30:** Si se encuentran **sin angina tras 5 horas de observación** en Urgencias, se darán de **alta desde Urgencias con doble antiagregación (AAS + Clopidogrel) + Bisoprolol/Amlodipino + parche de NTG 5 mg**.

• **3) Prevención de dobles dosis antitrombóticas:** En Urgencias administrar **SOLO AAS 300 mg**. En Código IAM la HNF y el 2.º antiagregante se ponen en Sala; en IAMSEST se pauta **Arixtra® 2,5 mg s.c.** al ingreso según protocolo UCO.

PARTICULARIDADES EN LA MUJER Y CHECKLIST DE TRASPASO A CARDIOLOGÍA

Cinco puntos clave en la mujer con SCA y verificación de seguridad antes del traslado a Planta / UCC

■ 5 PUNTOS CLAVE EN LA MUJER CON DOLOR TORÁCICO

• **1. Reconocimiento sin sesgo:** Además de opresión retroesternal, buscar dolor interescapular, mandíbula, epigastrio, disnea brusca, náuseas o fatiga extrema.

• **2. Umbral hs-cTnI específico:** Aplicar siempre **> 15,6 ng/L** en la mujer (frente a > 34,2 ng/L en el hombre) para evitar un 20–30% de infradiagnóstico.

• **3. Disección Coronaria Espontánea (SCAD):** Causa principal de IAM en mujeres ≤ 55 años y en el periparto. Si flujo TIMI 2–3 y estable → manejo conservador sin stent.

• **4. MINOCA y Takotsubo:** Si las arterias epicárdicas no tienen estenosis ≥ 50%, no dar de alta como normal: solicitar **RM Cardíaca precoz**.

• **5. Prevención del sangrado:** Ajustar heparinas al peso real y al filtrado glomerular (CKD-EPI) y priorizar el acceso radial.

■ CHECKLIST DE TRASPASO URGENCIAS -> CARDIOLOGÍA

• ■■ **1. Ubicación y Monitorización:** Cama monitorizada en Box de Críticos u Observación A y traslado con monitor/desfibrilador.

• ■■ **2. Registro Exacto de Antitrombóticos:** Hora y dosis exacta de AAS, anticoagulante (HNF, Enoxaparina o Fondaparinux) y si lleva o no P2Y12.

• ■■ **3. Alerta de Fondaparinux para el Lunes:** Anotar en orden de Hemodinámica: *«En tratamiento con Fondaparinux s.c. → Administrar bolo HNF 70-85 UI/kg i.v. el lunes en Sala»*.

• ■■ **4. Analítica Completa de Ingreso:** hs-cTnI 0h/2h, Creatinina/FGe, Hemograma, Coagulación, Perfil lipídico completo, HbA1c y NT-proBNP.

• ■■ **5. Tratamiento Precoz en las Primeras 24 h:** Atorvastatina 80 mg (o Rosuvastatina 20-40 mg) + Pantoprazol 40 mg + Betabloqueante si FEVI ≤ 40% y Killip I.

FILTRO DE TROPONINA SIN DOLOR TORÁCICO Y APP INTERACTIVA (CHGUV)

Prevención de llamadas innecesarias a Cardiología ante Daño Miocárdico / IAM Tipo 2 y uso de la App

■ PREGUNTA 0: TROPONINA ELEVADA SIN DOLOR TORÁCICO

• **Regla de Oro (5.ª Def. IAM / ESC 2023):** Una **hs-cTnI > p99 SIN dolor torácico** ni ascenso del ST define un **Daño Miocárdico** o un **IAM Tipo 2**, **NO un SCA Tipo 1**.

• **PROHIBIDO iniciar Doble Antiagregación (DAPT):** Sin placa rota no aporta beneficio y multiplica el sangrado grave (anemia, sepsis, ictus, ERC).

• **NO llamar a Cardiología de Guardia de rutina:** Manejar la causa desencadenante:

1) **Taquiarritmia (FA rápida):** Control de FC.
2) **Sepsis / Neumonía / Hipoxemia:** O2 y antibiótico.
3) **IC Aguda / EAP:** Diuréticos i.v. y NT-proBNP.
4) **Anemia / Sangrado / Hipotensión:** Transfusión/volumen.
5) **ERC (Δ < 20%):** Daño crónico estable.
6) **TEP / Ictus:** Angio-TC pulmonar / manejo neurológico.

■ FUNCIONAMIENTO DE LA APP INTERACTIVA (STREAMLIT)

• **1. Pantalla Previa de Aceptación (Disclaimer):** Exige aceptar que la herramienta es solo de apoyo para facilitar la revisión de los documentos del protocolo.

• **2. Pregunta 0 Obligatoria (Filtro Maestro):** Pregunta primero **«¿El paciente consulta por dolor torácico?»**. Si se elige **NO**, bloquea el formulario de SCA y muestra la guía de Daño Miocárdico / IAM Tipo 2. Solo si se elige **SÍ** se abre el algoritmo de SCA.

• **3. Filtrado Progresivo (Izquierda y Derecha):** Oculta troponinas cuando no proceden y muestra únicamente la dosis exacta del perfil elegido.

• **4. Pestaña 4 (Descarga de PDFs):** Descarga directa en PDF del Documento del Protocolo y de esta Presentación.